Диагноз: Не малобольшой клеточный рак легких

Лечение 1: Афатиниб

Выбранные клинические испытания:

1. 'Understanding Mechanisms of Acquired Resistance to BIBW2992' завершено bibw 2992 https://clinicaltrials.gov/study/NCT01074177

   Население: 14

   Время: В момент прогрессирования болезни (медианный срок от начала лечения составлял 11,4 месяца)

   Мутация T790M: 4

1. 'GIOTRIF rPMS в корейских пациентах с NSCLC' завершено giotrif 20mg giotrif 40mg giotrif 30mg https://clinicaltrials.gov/study/NCT02285361

   Население: 14

   Время: В момент прогрессирования болезни (медианный срок от начала лечения составлял 11,4 месяца)

   Мутация T790M: 4

1. 'LUX-Lung 4: BIBW 2992 (Афатиниб) фаза I испытания в пациентах с продвинутым не малобольшой клеточным раком легких & фаза II испытания в пациентах с не малобольшой клеточным раком легких, не отвечающих на эрлотиниб или гевитиниб' завершено bibw 2992 ma2 40mg/day bibw 2992 ma2 50mg/day bibw 2992 ma2 20mg/day bibw 2992 qd https://clinicaltrials.gov/study/NCT00711594

   Население: 14

   Время: В момент прогрессирования болезни (медианный срок от начала лечения составлял 11,4 месяца)

   Мутация T790M: 4

1. 'Исследование наблюдает, насколько долго пациенты с не малобольшой клеточным раком легких (NSCLC) получают пользу от лечения ингибитором эпидермального фактора роста тирозинкиназы (EGFR-TKI), когда препарат назначают либо для редких мутаций, либо для распространенных мутаций в последовательности афатиниб, за которым следует осимертиниб' завершено афатиниб (gi(l)otrif®) эрлотиниб (tarceva®) гевитиниб (iressa®) осимертиниб (tagrisso®) афатиниб (gi(l)otrif®) осимертиниб (tagrisso®) https://clinicaltrials.gov/study/NCT04179890

   Население: 14

Время: В момент прогрессирования болезни (медианный срок от начала лечения составлял 11,4 месяца)

Мутация T790M: 4

1. 'Оценка влияния афатиниба на качество жизни и нагрузку симптомов греческих пациентов с продвинутым NSCLC в условиях обычного ухода за пациентами' завершено афатиниб https://clinicaltrials.gov/study/NCT02440854

Население: 14

Время: В момент прогрессирования болезни (медианный срок от начала лечения составлял 11,4 месяца)

Мутация T790M: 4

1. 'LUX-Lung 5: Афатиниб в комбинации с недельной паклитакселом против выбора исследователя по однократной химиотерапии после монотерапии афатинибом у пациентов с не малобольшой клеточным раком легких, не отвечающих на эрлотиниб или гевитиниб' завершено выбор химиотерапии исследователя bibw 2992 https://clinicaltrials.gov/study/NCT01085136

Население: 14

Время: В момент прогрессирования болезни (медианный срок от начала лечения составлял 11,4 месяца)

Мутация T790M: 4

1. 'Пембролизумаб и афатиниб у пациентов с не малобольшой клеточным раком легких с устойчивостью к эрлотинибу' завершено афатиниб дималеат https://clinicaltrials.gov/study/NCT02364609

Население: 14

Время: В момент прогрессирования болезни (медианный срок от начала лечения составлял 11,4 месяца)

Мутация T790M: 4

Выбранные научные статьи:

Афатиниб одобрен для первичного лечения в продвинутом EGFR-мутационно положительном NSCLC [1]. Афатиниб показал потенциал в улучшении исходов лечения у пациентов с NSCLC [2]. Афатиниб показал эффективность у пожилых пациентов с EGFR-мутационным раком легких [3].

[1] Prospective Observational Real-World Study of Afatinib as First-Line Treatment in Patients with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation-Positive Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) in China. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41736995

[2] EGFR and IRE1α pathways are associated with distinct immunomodulatory gene expression profiles in NSCLC cells with acquired resistance to EGFR TKIs. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41672191

[3] Efficacy and safety findings of the EXTRA study in older adult EGFR-mutant lung cancer

patients receiving afatinib as first-line treatment. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41673455